

Forta Match

AI Matching & Doorverwijzing

Pilot 1a & 1b · Projectbeschrijving

In de volgende hoofdstukken vind je de learnings naar
aanleiding van het gesprek met secretariaat



Wat hebben we geleerd — Forta Volwassenen secretariaat

Forta Match

› Drie instroomkanalen = drie kwaliteitsniveaus

Zorgdomein = compleet. ZIVVER = matig compleet. Mailbox = vaak incompleet. "Compleet" zegt nog niets over de klinische inhoud — alleen over benodigde data.

› Veel werk gaat naar het compleet maken

Brieven niet via gestructureerd formulier zijn vaak incompleet. Veel heen-en-weer-vragen om data alsnog rond te krijgen.

› Aanmelden in Medcore is een aparte stap

Zorgdomein-brieven worden automatisch geregistreerd. Andere kanalen: secretariaat maakt eerst een cliëntkaart aan in Medcore vóór beoordeling.

› Locatie zoeken — een ergernis

Uitzoeken van dichtstbijzijnde locatie is handwerk (googlen). Geen tooling, geen gestandaardiseerde lookup.

› Harde ADHD-regel: alleen bestaande diagnose

Enkelvoudige ADHD-diagnostiek wordt niet gedaan. Geen diagnose → "rood" exclusie criterium. Er wordt niet gekeken of dit Forta-breed kan worden opgepakt.

› Label-overstijgend matchen gebeurt niet

Niet passend bij het label? Dan terug naar arts — zonder te kijken of het bij een ander Forta-label past. Pure ja/nee per label.

› Handboek wordt geïnternaliseerd

De feitelijke screening gebeurt op basis van een geïnternaliseerd handboek. Kennis zit grotendeels in hoofden van het secretariaat.

› Geen geavanceerde matching aanwezig

Matching op label-overstijgende criteria, verzekeraarplafonds, beschikbaarheid of locaties wordt niet gedaan. Daar zit juist de waarde van Forta Match.

› Groen / Oranje / Rood — huidige triage

Secretariaat gebruikt kleurcodering. Groen = direct verwerken, Oranje = twijfel → screenteam, Rood = afwijzen.

› ~40% gaat naar het screenteam

Complexe of onduidelijke hulpvragen worden telefonisch beoordeeld. Terugkoppeling naar secretariaat alleen bij afwijzing of onbereikbaarheid.

› Interne doorverwijzingen handmatig & foutgevoelig

Doorverwijzingen naar Psytrek, intercultureel en jeugd vereisen extra handmatige stappen. Risico op fouten.

› Secretariaat staat open voor verbetering

Geïnterviewd secretariaat staat open voor een verbeterd proces en AI-hulp die matching makkelijker maakt.

Wat hebben we geleerd — Psytrec gesprek

Forta Match

› Eén formaat, twee soorten verwijzers

Verwijsbrieven komen van huisartsen en (GZ-)psychologen. Eén simpel formaat, geen Zorgdomein-zwaarte zoals bij Forta Volwassenen.

› Aanmelden via eigen website

Clîent meldt zich zelf aan via website + uploadt verwijsbrief. Komt direct in Medico. BSN + geldig legitimatiebewijs verplicht.

› Verwijzers weten niet waar Psytrec voor staat

Verwijzers worstelen met "naar wie verwijst ik?". Psytrec = medisch expert PTSS + persoonlijkheid. Eigen format-jes komen ook binnen.

› BIG-register validatie op verwijzer

Verwijzer gecontroleerd in BIG-register. Niet gevonden → handmatig invoeren in Medico. Niet automatisch geblokkeerd.

› Géén exclusie op suïcidaliteit of persoonlijkheid

Anders dan andere labels: suïcidaliteit en persoonlijkheidsproblematiek zijn geen knock-outs — die horen bij het profiel.

› PTSS-check via vragenlijst (1, 2 en 9)

Standaard PTSS-vragenlijst per mail. Drie kernvragen (1, 2, 9) moeten op "ja" staan. Herbeleving wordt op twee manieren uitgevraagd.

› Aanvullend gescreend: persoonlijkheid + gedrag

Niet alleen PTSS — ook of er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek, borderline-trekken of gedragsproblematiek.

› Nederlands of Engels — beide goed

Behandeling kan in het Nederlands of in het Engels. Geen taal-knock-out.

› Vragenlijst eerst per mail, dan pas telefonisch

Na aanmelding: PTSS-vragenlijst per mail. Geen reactie → opvolging telefonisch. Geen directe intake.

› 85% gaat door naar intake

Conversieratio van aanmelding naar intake is ~85%. De vragenlijst-stap filtert het leeuwendeel uit.

› Intake: klinisch interview + comorbiditeit-check

Eerste intake: PTSS-check via klinisch interview, beoordeling comorbiditeit en suïcidaliteit. Indien aanwezig → tweede intake door verpleegkundige.

› Locatie + online

Behandeling kan op locatie of online. Beide aanbod-vormen vallen onder Psytrec.

Wat hebben we geleerd — Impegno Ede (WMO)

Forta Match

› Vier instroomkanalen, KCC zou de poort moeten zijn

Aanmelding via website, telefoon, mail of telefonisch via. Klant Contact Centrum (KCC) moet als gatekeeper functioneren. Vaak wordt deze overgeslagen en pakken lokale teamleden de aanvraag op. Verwijzingen gaan latijd via de gemeente

› WMO-consulent als verwijzer

Gemeente verwijst via WMO-consulent. Anders dan bij Forta-labels — geen huisarts of psycholoog. Als het om een ci gaat moet de lokale Impegno deze case oppakken. Screening is dan al gedaan. Het andere scenario moet er wel een matching plaats vinden.

› Te complex? Terug naar WMO-consulent

Als zorg te complex blijkt voor Impegno → terug naar WMO-consulent. Die regelt het ergens anders. Impegno doet niet alles binnen WMO.

› Stakeholder: Aicha Prooij

a.prooij@impegno.nl. Primaire contactpersoon voor inhoudelijke afstemming over Ede en KCC-proces.

› Compacte exclusielijst

Slechts een paar harde uitsluitingen: 18-min uitgesloten (jeugd elders), geen postadres / niet ingeschreven in gemeente. Verder weinig vaste regels.

› Géén label-overstijgende check

er wordt nietstructureel gekeken of een andere Forta-label past. Pure ja/nee voor dit label.

› HYbride aanbod beschikbaar

Naast fysieke ondersteuning ook online aanbod. Nooit alleen online, dus hybride aanbod. Geen aparte routing — gewoon onderdeel van het Impegno-aanbod.

› Handboek leidend voor in/exclusie

Inclusie- en exclusiecriteria leven in het handboek. KCC-screening en team-beoordeling volgen dit handboek bij twijfel.

› KCC-screening: BSN → risico → dossier → vragenlijst

Stappen: aanmelding afchecken, BSN-controle, case-of-beschikking check, risicotaxatie, dossiercontrole, vragenlijst. Dan eerste screen door team.

› Match → huisbezoek

Bij match volgt een huisbezoek. Daar wordt helder of de match echt past. Geen aparte intake-fase zoals bij andere labels.

› gemeente hebben verschillende -budgetafspraken —

Sommige gemeenten hebben geen plafond per cliënt. Andere hebben wel heldere budget afspraken. Sturing via PMAQ-cijfers: inwoners per maand, uren per maand, uren per cliënt. Capaciteits-rekenen anders dan bij DBBC-labels.

› Caseload-app uit, terug naar Excel

Caseload-app wordt niet meer bijgewerkt → 20 teams werken weer in Excel-lijsten (aanmeldijst, oppaklijst). Tijdelijke opvang via andere labels bij overloop.

verwijsbrief voor regulier specialistische GGZ ZorgDomein

Verzender

Naam:
AGB-code:
Organisatie:
Org. AGB-code:
Adres:
Woonplaats:
Tel:
Intercollegiaal overleg:

Patiënt

Naam:
Geboortedatum:
BSN:
Adres:
Woonplaats:
Tel:
Tel mobiel:
Zorgverzekeraar:
Verzekeringsnummer:
E-mailadres:

Verwijzing

Datum: 27-02-2026 08:15
ZD-nummer: ZD194240016
Organisatie: Forta, Digitale Poli
Org. AGB-code: 73732118

Naam zorgproduct: regulier specialistische GGZ
Toegangstijd: 77 dagen
Zorgvraag: Geestelijke gezondheidszorg > ADHD
Adres: Demkaweg 11 DG
Woonplaats: 3555 HW Utrecht

Kerndeel

06-03-2026 15:38

Geachte collega,

Reden van verwijzing,
vraagstelling

Is er sprake van ADHD?
Zie onderstaande consult:

S/ In vg angst/paniekaanvallen, waarvoor gesprekken bij POH GGZ. Laatste jaar bij Gestalt therapeut. Daar mogelijkheid van ADHD besproken. Terugkijkend veel spanning/angst bij nieuwe baan. Alvast medicatie starten?

E/ dd ADHD is ingewikkeld, zeker bij volwassenen. Niet zo beginnen met medicatie, eerst goed diagnostisch onderzoek.

Heraanmelding

nee

Vermoeden DSM 5
stoornis(sen)

ADHD

Journal

19-02-2026 (sombere gedachten, P03)

(S) - voicemail ingesproken, over diagnose ADHD, waar gesteld? afspraak plannen bij huisarts die dhr goed kent.

17-02-2026 (sombere gedachten, P03)

(P) - Van:PSY, ADHD

15-05-2025 (sombere gedachten, P03)

(S) - BG TC: heeft een andere therapeut gevonden. Afspraken Jörn hoeven niet door te gaan

19-11-2024 (sombere gedachten, P03)

(S) - POH GGZ JJ: pt is in balans met zichzelf, erkent dat een veeleisende werkomgeving ook bekend is door zijn gezin van herkomst, uitdaging in de ontspanning en het mogen ipv moeten. Samen

voorbeeld verwijsbrief

besloten dat we de begeleiding beëindigen vanuit POH GGZ. In geval van neemt pt weer contact op, pt heeft een gevoeligheid om te verkrampen en daarmee vast te lopen.

Relevante probleem-
/epistelijst

Open episodes

07-11-2025, status na BLWI
02-04-2019, sombere gedachten

Psychiatrische
voorgeschiedenis

Angst en paniek aanvallen. -> POH GGZ

Medicatie actueel

Geen

Besproken met patiënt

Alles

Procedurevoorstel

Verdere diagnostiek

Ook bekend bij

-

Suïcidaliteit

nee

Aanvullend deel

E-mailadres patiënt

Met collegiale groet,



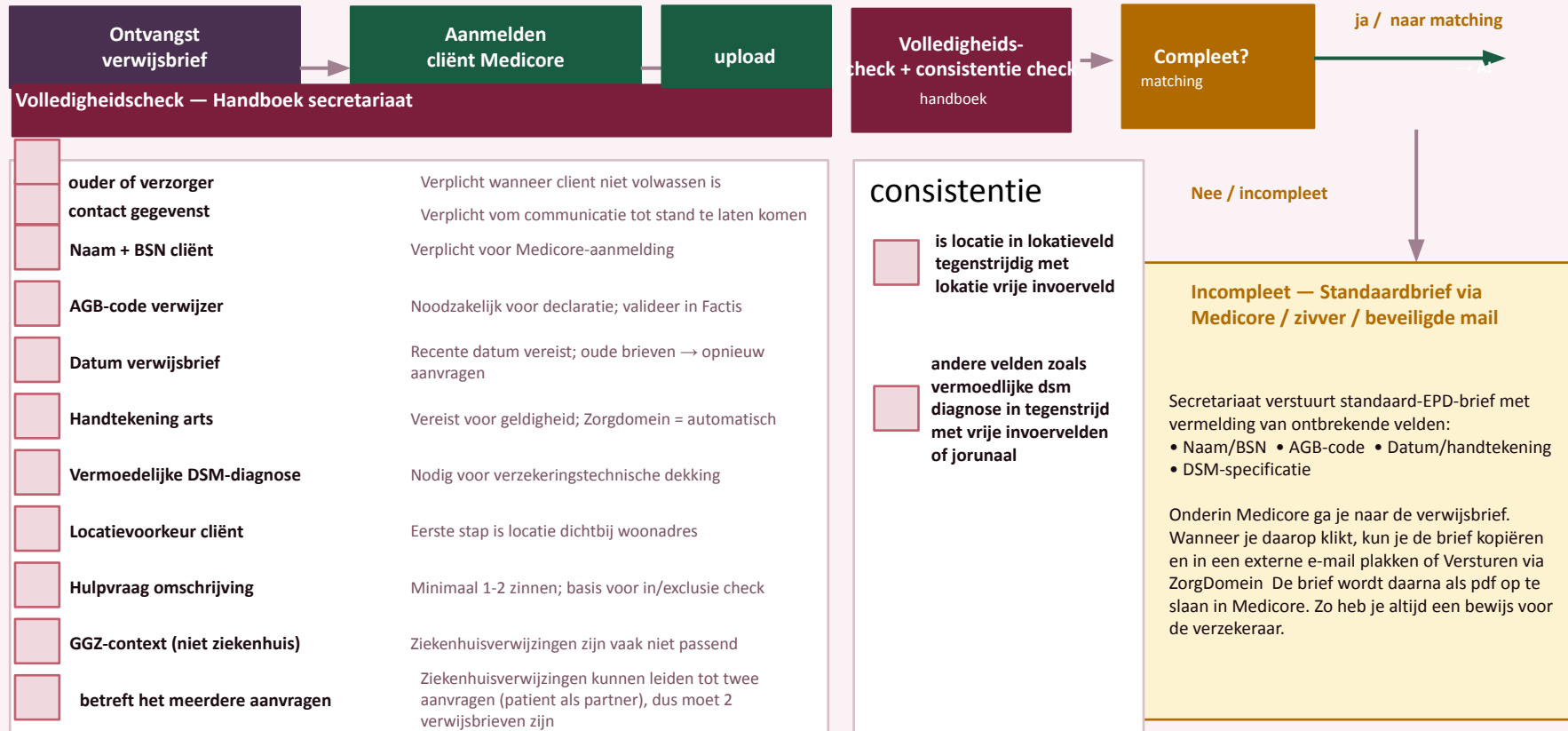
Wat we hebben geleerd: Verwijskanalen & Kwaliteitsverschillen

Zorgdomein	ZIVVER / ZorgMail	Mailbox (beveiligd / regulier)
● Compleet Gestructureerde portal van huisarts. Formulier dwingt invulling af van alle verplichte velden. ✓ gegevens client (BSN = contact) ✓ AGB-code verwijzer ✓ Datum + handtekening ✓ Vermoedelijke DSM ✓ Hulpvraag Ideale input voor LLM-extractie — minimale pre-processing nodig.	● matig compleet Beveiligd e-mailsysteem. Beter gestructureerd dan reguliere mail, maar geen formulierverplichting, dit betekent dat kwaliteit sterk afhankelijk is van de afzender. Kwaliteit dus inconsistent. ✓ gegevens client (BSN = contact) - DSM (soms vaag omschreven of verwarrend gesteld) ~ AGB-code (niet altijd) ~ Handtekening (soms ontbreekt) - Hulpvraag (wisselend) Niet altijd consistente input. AI moet AGB-code en handtekening apart valideren.	✗ Vaak incompleet E-mail via info@-adres of beveiligde mailbox. Geen structuur — secretariaat volgt handboek voor check. ✓ gegevens client (BSN = contact) ✗ AGB-code (vaak ontbreekt) ✗ Handtekening (vaak ontbreekt) ✗ Datum (soms) ~ DSM (vaag / onjuist) Vraagt extra volledigheidcheck vóór AI-analyse. Standaardbrief via Medicore bij ontbrekende velden. Ziekenhuisverwijzingen ⚠

Komen vaak binnen via mailbox, gericht aan huisarts, met onvoldoende GGZ-context. 9 van de 10 voldoet niet aan criteria. Hoog volume handmatig terugstuurwerk → kans voor AI-signalering.

Stap 1 — Volledigheidscheck

Vóór AI-analyse: secretariaat registreert altijd eerst de cliënt in Medicore. Pas daarna volledigheidcheck.



Stap 2 AI Extractie & matching

Forta Match · Pilot 1a

✓ Via Zorgdomein — Compleet

ZD194240016 · 27-02-2026

Stap 2 — LLM Extractie (Gemini)

✓	Woonplaats	3555 HW Utrecht
⚠	DSM-5 vermoeden	ADHD
✓	Klachten & hulpvraag	Angst / paniekaanvallen, spanning, vermoeden ADHD
✓	Leeftijd / categorie	Volwassene (spec. GGZ)
✓	Soort GGZ	Regulier specialistische GGZ
~	AGB-code type	Org: 73732118 — verwijzer: [afgeschermd]
✓	Verwijsdatum	27-02-2026 (47 dagen geleden)
✓	Suïcidaliteit	Nee (expliciet benoemd)
✗	Procedurevoorstel	Verdere diagnostiek — GEEN bestaande diagnose
~	Journal signalen	Sombere gedachten P03, angst/paniek, POH GGZ

tagging

Stap 3 — Rules Engine uitkomst

📍 Locatie + reistijd

3555 HW Utrecht → Forta locatie nabij. Reistijd: acceptabel.

✓ Inclusiecriteria

GGZ spec. aanwezig. Klachtprofiel: angst/paniek. Leeftijd: volwassene. → Match mogelijk.

✓ Exclusiecriteria

actieve verslaving, psychose, forensisch profiel gedetecteerd, suicidaliteit

~ Verzekeraarplafond

Zorgverzekeraar aanwezig in brief. Plafond check

~ Beschikbaarheid / wachttijd / capaciteit

Toegangstijd: 77 dagen.

✗ exclusie ADHD-regel (HARD)

Aanvraag = DIAGNOSTIEK ('Is er sprake van ADHD?'). Geen bestaande diagnose → AUTO NEE.

✓ Oncologie → Vruchtenburg

Geen oncologische hulpvraag. Regel niet van toepassing.

Stap 3 - advies / match

Wat ziet het secretariaat in de tool?

AI-advies + confidence score

Ja / Twijfel / Nee met procentuele zekerheid

Geëxtraheerde signalen

DSM, klachten, leeftijd — highlights in de brief

Gematchte labels (ranked)

Top-3 labels met score en motivatie

Exclusiehits (rood gemarkeerd)

Welk criterium zorgt voor afwijzing?

Volledigheids-score brief

Welke criteria zijn niet aanwezig?

splitsing online
and offline
aanbieders

GESORTEERD OP GESCHIKTHEID — 5 OPTIES BEOORDEELD

Beste optie **Aanbevolen**

Label A — Locatie 1 (Delft)

+28

ADHD diagnosticering +8

Vermoeden autisme +6

Leeftijd 18-30 +5

Reistijd <30 min +3

Wachttijd <12 wkn +3

Somberheid (neutraal)

2e optie

Label A — Locatie 2 (Leiden)

+19

ADHD diagnosticering +8

Vermoeden autisme +6

Leeftijd 18-30 +5

Reistijd >30 min -3

Geen wachtlijddata

3e optie

Label B — Locatie 1 (Zoetermeer)

+12

ADHD diagnosticering +8

Leeftijd 18-30 +5

Reistijd >30 min -3

Afwijkende routes

Doorsturen

Screenteam — Twijfelgeval

+8

Somberheid (ambigu) +8

Geen harde uitsluitcriteria aanwezig

Afwijzen

Buiten behandelkader

0

Enkelvoudige ADHD vraag — niet aanwezig

Psychose — niet aanwezig

Screen team proces (~40% van aanmeldingen)

Trigger → Screenteam

- AI-advies = TWIJFEL (oranje)
- Secretariaat override naar oranje
- Complexe comorbiditeit
- Onduidelijke hulpvraag
- DSM vermoeden klopt niet met brief
- Speciale doelgroep (intercultureel)
- ~40% van alle aanmeldingen

Screen team MANUEEL Proces

- Brief ontvangen**
Inclusief AI-advies + extractie
- Telefonisch contact**
Cliënt gebeld — klacht verduidelijken
- Geen contact?**
Opvolging via mail. Max 2 pogingen.
- Beslissing**
Ja / Nee + korte motivatie
- Feedback naar model**
Beslissing + argumentatie opgeslagen
- ?**
Additionele uitvraag
Via Kompas (indien behandelrelatie check)

Terugkoppeling & Feedback

→ Secretariaat

- Alleen bij:
- Afwijzing (+ reden)
 - Cliënt niet bereikbaar (na 2 pogingen)

→ AI Model

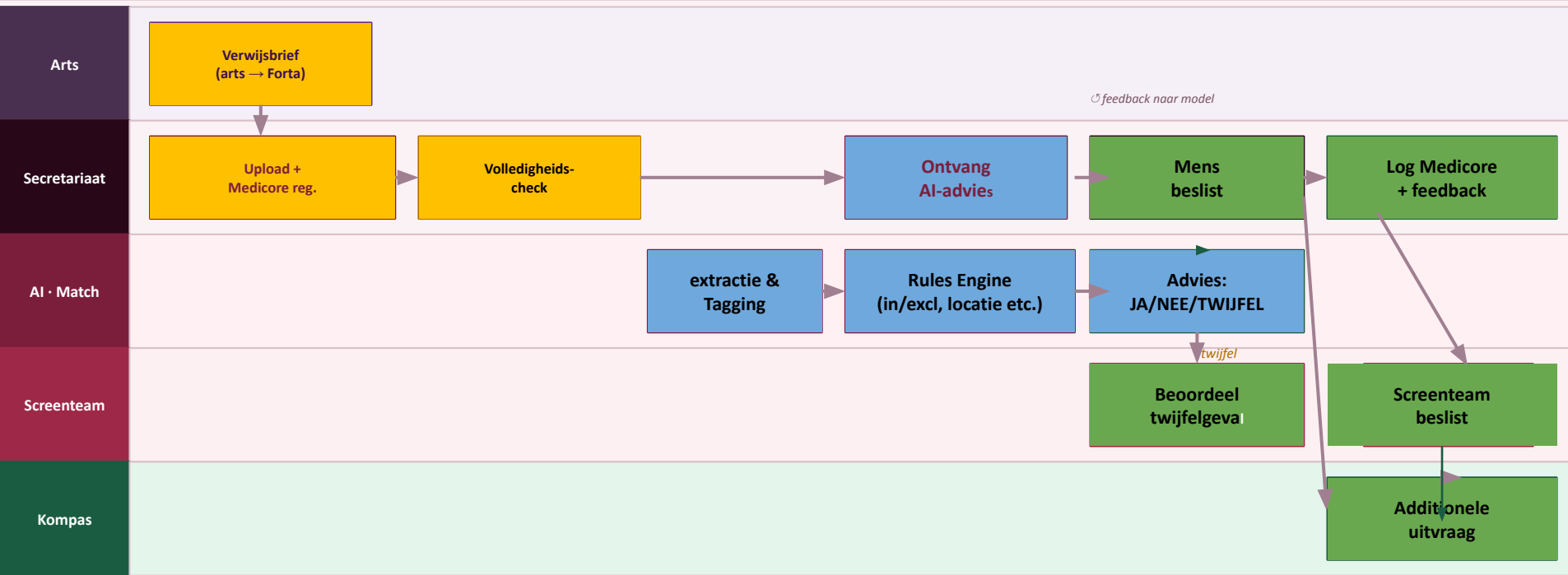
- Elke beslissing wordt opgeslagen als feedback:
- Ja / Nee + motivatie
 - Basis voor verbetering model over tijd
- vastlegging epd?**

→ Medcore

Uitslag gelogd op cliëntkaart + label-koppeling bijgewerkt

Volledig Process diagram — Forta Match (o.b.v. Secretariaat Interview)

Forta Match



■ AI stap

■ Secretariaat

■ Screenteam

■ Kompas / Ja

■ Afwijzing

↺ Feedback loop

Forta Match

AI Matching & Doorverwijzing

Pilot 1a & 1b · Projectbeschrijving

Forta Match reduceert de handmatige werklast bij patiëntmatching — AI tagt de verwijfsbrief, de mens beslist en bewaakt.



Huidige situatie

Secretariaat matcht verwijfsbrieven handmatig aan Forta labels — tijdrovend, inconsistent en afhankelijk van individuele kennis van in/exclusiecriteria.



Oplossing

AI analyseert de verwijfsing en bepaalt de best passende route over labels en behandellijnen heen. Het systeem adviseert niet alleen *wat* past, maar ook *waar* plek is — en verdeelt cliënten consistent en datagedreven over de organisatie.



Strategisch doel

Meer consistentie bij matching, en een basis voor centraal, capaciteitsgestuurde planning via Kompas.

Mens beslist altijd

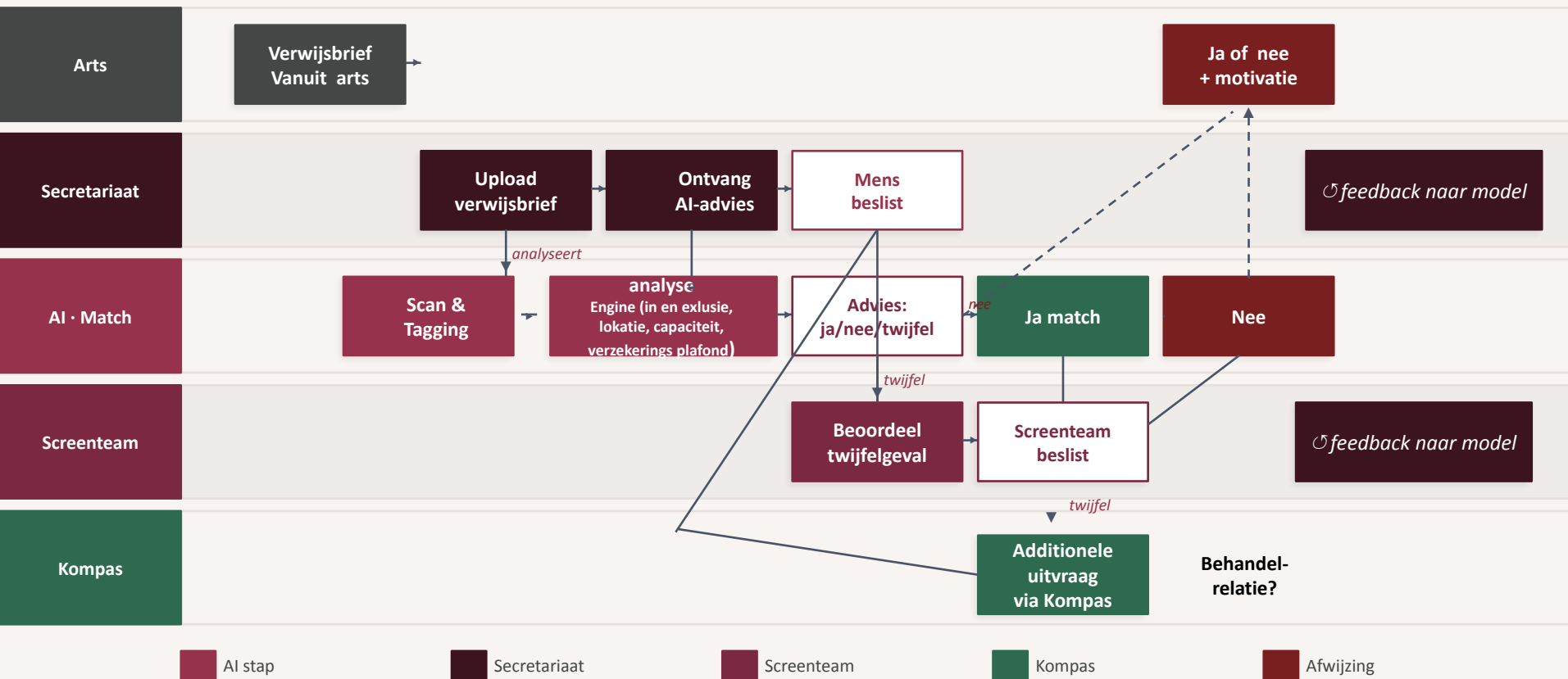
AI adviseert

Schaalbaar

Privacy by design

Proces flow

Forta Match



Pilot 1a & 1b — Scope &

meerdere
secretariaten
toevoegen als
tussenstap

mens vs mens =
max score

digital zorg - intern
doorverwijzen - eerste
instap zijn

Pilot 1a *1 secretariaat · ≥ 4 labels*

Doel	Bewijzen dat AI kan taggen, een -advie op basis van een rule engine kan geven. En dat het advies overeenkomt met het oordeel van de menselijke beoordelaar.
Aanpak	AI draait parallel aan het huidige werkproces — secretariaat werkt gewoon door
UI	Beperkt: schrijf je beoordeling zelf, upload brief, bekijk advies, geef feedback,
AI-scope	LLM-extractie + prompting (secretariaat document) ≥ 3 labels van Forta Volwassenen
Validatie	Parallelrun: AI-advies vs. menselijke beslissing — blind vergeleken
labels	Forta volwassenen, DR BOSMAN, Human concern, psytrack

Pilot 1b *>4x secretariaat · 4 labels*

Doel	bewijzen dat voorgaande doelen (pilot 1a) gescaled kunnen worden over meerdere labels en secretariaten
Aanpak	AI draait over de verschillende secretariaten.
UI	Beperkt: schrijf je beoordeling zelf, upload brief, bekijk advies, geef feedback,
AI-scope	LLM-extractie + prompting (secretariaat document) ≥ 3 labels van Forta Volwassenen
Validatie	Parallelrun: AI-advies vs. menselijke beslissing — blind vergeleken
Labels	Forta volwassenen, DR BOSMAN, Human concern, psytrack

Pilot 1c *≥ 4 secretariaten - screen team · ≥ 4 labels*

Doel	Consistentie van AI-advies over meerdere secretariaten en meer labels aantonen
Aanpak	Uitrol naar ≥ 3 secretariaten + integratie screenteam-workflow in de tool
UI	Volledig: advies-queue, door verwijzing naar screen team, screenteam-module, PDF-export
AI-scope	rLLM-extractie + prompting (secretariaat document) ≥ 3 secretariaten, 6 labels van Forta Volwassenen
Validatie	User testing + uitkomstvalidatie + consistentiecheck tussen secretariaten
Start	Forta volwassenen, DR BOSMAN, Human concern, psytrack

Exit: >85% overeenkomst AI vs. mens
• Gebruikersfeedback op basis van ai advies is

Mvp definitie

Forta Match

MVP

*alle secretariaten · alle labels –
screenteam + beheeromgeving*

nog te maken

Human in de Loop — Wie beslist wat?

Forta Match

AI adviseert. Mensen beslissen. Hier is exact gedefinieerd op welk moment welke rol welke bevoegdheid heeft.

Processtap	AI doet	Mens doet	Override?
1. Briefanalyse	Scant brief, kent tages toe, geeft confidence score	Secretariaat ziet advies + score — valideert of het klopt	Ja
2. Ja-advies	Adviseert label op basis van in/exclusie + (capaciteit(tbd)) + locatie / reistijd, (verzekering plafond, tbd)	Secretariaat bevestigt of kiest zelf een ander label	Ja
3. Twijfel-advies	Geeft twijfelsignaal / lage confidence score+ onderbouwing aan secretariaat	Secretariaat stuurt door naar screenteam. Screenteam beslist	Ja
4. Nee-advies	Geeft afwijzingsadvies + reden	Secretariaat valideert de afwijzing voor terugkoppeling arts en terugkoppeling naaar systeem	Ja — altijd
5. Naar screenteam	geeft inzicht in initieel advies richting secretariaat. S	creenteam kan aanvullende vragen stellen via Kompas. Of maakt besluit. Stelt ai op de hoogte van besluit en korete feedback / argumentatie.	Ja
5. Additionele vragen forta Kompas	Ai geeft advies over aanvullende vragen	seceratariaat voegt vragenlijst toe via Kompas en verstuurt richthing patient of arts.	Ja

Data Vereisten — Bronnen & Status

minimaal 1
brief op basis
criteria.

voorwaarden
/
onvoldoende
verwijsbrief,
hoe vaak
gebeurt dat

Match

data an

loop n
huisa

klankbord,
meehelpen
met schrijven
instructies

locatie
persoon zelf

Data element	Formaat	Bron / eigenaar	Status
Verwijsbrief	PDF / Word / ZorgMail	Arts via secretariaat	OK — formaat TBD per locatie
In/exclusiecriteria	Gestructureerd (format TBD)	Label-eigenaren Forta	⚠️ partieel beschikbaar — aangeleverd v label / geoptimaliseerd voor een Ilm / te n interpretabel
Lokatie info (label, locatie, expertise, type behandelingen, klachtprofielen	Lijst + metadata	Forta centraal	⚠️ Partieel beschikbaar
Gemiddelde wachttijden	Getal per label/locatie	Planning / Kompas — koppeling?	❌ Bron niet bepaald
Capaciteit per locatie	Beschikbare plekken + plafonds	Planning / HR — koppeling?	❌ Bron niet bepaald
Verzekeringplafond	Per patiënt / periode / label	Financiën / EPD	❌ Bron niet bepaald
Historische matches (?)	Trainingsdata AI	Archief secretariaat	⚠️ Volume & kwaliteit onbe

⚠️ 4 van 7 databronnen hebben geen eigenaar of bron. Dit is een kritisch risico voor de pilot — aanwijzen vóór start bouw.

Backoffice & Beheer Use Cases

Forta Match

Secretariaat

PILOT 1A

- Verwijsbrief uploaden (PDF / bulk)
- AI-advies bekijken met confidence score en rule based results
- accordering / feedback
- reageren op rule based results
- additionele vragen via kompass
- verwijzen naar screenteam
- PDF-export advies voor dossier / follow up?

Screenteam

PILOT 1B

- verwijsbrief selectie
- AI-advies bekijken met confidence score en rule based results
- reageren op rule based results
- accordering / feedback
- additionele vragen via kompass
- PDF-export advies voor dossier / follow up?

dashboard (post mvp)

Post pilot

- facts and figures doorverwijzingen
- Dashboard: feedback van secretariaat
- Wachttijden per label monitoren
- In/exclusiecriteria beheren
- trends
- locatiebeheer
- verzekerasr plafond beheer

Open Beslissingen — Dit moet beantwoord zijn vóór de bouw start Forta Match

01	AI-drempelwaarden Wanneer is het JA, NEE of TWIJFEL?	er is geen definitie van de confidence-score drempel. Zonder dit kan de AI niet geconfigureerd worden.	Actie: Definieer drempelwaarden (bijv. >80% = ja, <40% = nee, rest = twijfel).
02	Labels Pilot 1a Welke 3 labels doen mee, en waarom juist die?	De keuze vrij bepalend voor traject, de criteria en de complexiteit van de pilot.	Actie: Labels aanwijzen met motivatie vóór start.
03	Kompas-koppeling Hoe gaat een match van Forta Match naar Kompas?	doorverwijzen via Kompas" Hoe zien we deze integratie? Handmatig kopiëren? API? Integratie?	Actie: Bepaal of Kompas-koppeling in scope is voor Pilot 1a of 1b. Eigenaar: technisch architect + Kompas-beheer.
04	Behandelrelatie check Wie doet de behandelrelatie-check en op basis van welke data?	Het probleem rondom "Behandelrelatie?" wanneer het besluit wordt genomen om verder uit te vragen via kompas. Moeten we beslissing op nemen	Actie: Beslissing nodig. Eigenaar: medisch/juridisch?
05	Screenteam workflow Hoe communiceert screenteam hun beslissing terug?	Besluit hoe het het screenteam via de tool reageert of buiten de tool om is nodig. Dit bepaalt of je een echte workflow moet bouwen of alleen een notificatie.	Actie: Kies: in-tool beslissing (meer bouw) of notificatie + extern proces.

Succescriteria & Go/No-Go

Forta Match

Criterium	Norm	Meetmethode	Pilot	Eigenaar
AI-accuracy vs menselijk oordeel	>85%	Parallelrun — beide beoordelen blind	1a	Product owner
Tijdsbesparing per verwijzing	>20%?	Tijdmeting secretariaat voor/na	1a	Product owner
Gebruikerstevredenheid	>7/10?	Survey na 4 weken gebruik	1a	Product owner
Privacy & compliance	DPIA ✓ NEN 7510 ✓	Audit voor livegang	1a	tech dev
Screenteam integr. functioneel	screenteam involved en heeft getest	Systeemlog + interviews	1b	product owner
Consistentie over secretariaten	>80% gelijk bij zelfde brief	A/B crosstest	1b	Product owner
Go/No-Go na Pilot 1a: alle 1a-criteria groen + open beslissingen opgelost → schriftelijke goedkeuring → start Pilot 1b				

Stakeholders

head of data - naam? Stan Aartzen

Label / Afdeling	Naam			Pilot-fase
Forta — Label 1	— in te vullen	— in te vullen	ja	1a
Forta — Label 2	— in te vullen	— in te vullen	Nee ✗	1a
Forta — Label 3	— in te vullen	— in te vullen	Nee ✗	1a
Forta — Label 4 (nader te bepalen)	— in te vullen	— in te vullen	Nee ✗	1b
Forta — Label 5 (nader te bepalen)	— in te vullen	— in te vullen	Nee ✗	1b
Forta — Label 6 (nader te bepalen)	— in te vullen	— in te vullen	Nee ✗	1b
Actie: per label een vertegenwoordiger benoemen die in/exclusiecriteria aanlevert in afgesproken formaat — deadline TBD.				
Privacy / DPO	— in te vullen	— in te vullen	Nee ✗	1a

parking lot

Wat hebben we geleerd — Secretariaat-interview Forta

Volwassenen

>

Drie instroom-kanalen = drie kwaliteitsniveaus
Zorgdomein = compleet. ZIVVER = matig compleet.
Mailbox = vaak incompleet (geen heldere vraag, context of klachtenbeeld, ontbreken datum of AGB-code). Compleet betekent vooral benodigde data, zegt nog niets over kwaliteit van klinische gedeelte

>

Label overstijgend matchen wordt niet gedaan
Niet passend bij het label? Dan wordt het teruggestuurd, zonder te kijken of het bij een ander label past.

>

cliënt wordt aangemeld in Medicores
(verwijsbrieven van zorgdomein worden automatisch geregistreerd)
Als de verwijzing Via andere kanalen wordt gedaan maakt secretariaat eerst een cliëntkaart aan in Medicores voordat er tot beoordeling wordt overgegaan

>

Een groot deel van het werk bestaat uit het compleet maken van de verwijsbrief
Veel verwijsbrieven die niet gemaakt zijn op basis van gestructureerd formulier - denk aan zorgdomein - zijn vaak incompleet Dit betekent veel heen en weer gevraagd van informatie.

>

Groen / Oranje / Rood — het huidige triage-systeem
Secretariaat gebruikt een kleurcodering. Groen = direct verwerken, Oranje = twijfel → screenteam, Rood = afwijzen

>

Het handboek wordt geïnternaliseerd
De feitelijke screening wordt gedaan op basis van een geïnternaliseerd handboek.

>

~40% gaat naar het screenteam
Complexe of onduidelijke hulpvragen worden telefonisch beoordeeld door screenteam.
Terugkoppeling naar secretariaat alleen bij afwijzing of onbereikbaarheid.

>

Harde ADHD-regel: alleen bestaande diagnose
Enkelvoudige ADHD-diagnostiek wordt niet gedaan. Cliënten zonder diagnose worden afgewezen — dit is een 'rood' exclusie criterium. Er wordt niet gekeken of dit Forta breed kennen worden opgepakt

>

Interne doorverwijzingen zijn handmatig & foutgevoelig
Doorverwijzingen naar Psytrek, intercultureel en jeugd vereisen extra handmatige stappen. risico op fouten.

>

Lokatie een ergenis bij secretariaat
Uitzoeken van dichtbijzijnde lokatie is handwerk (googlen)

>

Geïnterviewd secretariaat open voor verbetering
Secretariaat staat open voor een verbeterd proces en ai hulp die matching makkelijker maakt

>

Er is geen geavanceerde matching aanwezig.
Matching op basis van label overstijgende criteria, verzekeraar plafons, beschikbaarheid / planning, lokaties wordt niet gedaan. En wordt gezien als waarde van ons project.